

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Salah Bounider- Constantine3

Faculté de Medecine Belkacem Bensmail-Departement de medecine

Service de Médecine Interne-CHU Dr Benbadis Constantine

Pr Houda Benabderrahmane

SEMIOLOGIE DES GLANDES SURRENALES

Plan du cours :

1 Rappel anatomophysiologique

A- Rappel Anatomique

B- Rappel Physiologique

2- Anomalies fonctionnelles des surrénales :

A-Insuffisance Surrénale Périphérique : Maladie d'Addison

B- Syndrome d'Hypercorticisme : Syndrome de Cushing

**Selon le Programme national d'enseignement semiologie 3eme année Médecine
Année Universitaire 2025-2026**

1-RAPPEL ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE

A - RAPPEL ANATOMIQUE :

Les surrénales sont 2 glandes endocrines situées à la partie haute et interne de la cavité abdominale rétro- péritonéales à droite et à gauche de la douzième vertèbre dorsale.

Elles sont constituées :

- d'une corticale : corticosurrénale
- une médullaire : médullo-surrénale

Ces 2 parties forment en fait 2 glandes complètement différentes physiologiquement.

B – RAPPEL PHYSIOLOGIQUE :

La corticosurrénale secrète 3 groupes d'hormones :

- les glucocorticoïdes (zone fasciculée)
- les androgènes surrénaliens (zone réticulée)
- les minéralocorticoïdes (zone glomerulée)

Les actions physiologiques sont :

a ► les glucocorticoïdes : l'hormone naturelle est le cortisol

● action sur le métabolisme protido-glucidique :

- métabolisme des glucides : action hyperglycémisante résultant de :

- augmentation de la néoglucogenèse (réserves)
- augmentation de la glycogénolyse (catabolisme)
- augmentation de la libération de glucose hépatique dans le sang

- métabolisme des protides :

- accélération du catabolisme musculaire, osseux, lymphoïde, conjonctif.

● action sur le métabolisme des lipides (graisses) :

Mobilisation des acides gras et des lipoprotéines et stockage en certains endroits de l'organisme (répartition centripète des graisses : facio-tronculaire).

● action sur l'eau et les électrolytes :

-à doses physiologiques : le cortisol provoque une diurèse sodée

-à doses plus fortes : l'action minérale apparaît entraînant une rétention sodée.

● action sur le sang :

mobilisation leucocytaire en particulier et peut être des plaquettes par contre atrophie lymphoïde et eosinopenie.

● action anti-inflammatoire et anti-allergique.

b ► les androgènes :

Leurs actions sont en général celles des hormones mâles :

- action sur les organes : développement des organes génitaux et des caractères sexuels secondaires (pilosité, musculature ...)
- action métabolique :
 - anabolisme protéique ;
 - catabolisme lipidique ;
 - légère rétention hydrosodée.

c ► les minéralocorticoïdes : l'hormone naturelle est l'aldostérone.

l'action physiologique de l'aldostérone se situe au niveau du rein où il provoque :

- une rétention de Na^+
- une fuite parallèle de K^+ et d'ions H^+

2- ANOMALIES FONCTIONNELLES DES SURRENALES

A- INSUFFISANCE SURRENALE PERIPHERIQUE

Un exemple d'étiologie : une étiologie auto-immune : la maladie d'Addison

- Forme de description : forme chronique (dite aussi forme lente) d'insuffisance surrénale périphérique

5 signes majeurs la caractérisent et permettent le diagnostic clinique :

1- L'ASTHENIE :

due au déséquilibre hydro-électrolytique :

- déficit en glucocorticoïdes → diminution excrétion de l'eau
- déficit en minéralocorticoïdes → fuite hydrosodée et rétention de K^+ .

Elle est particulière par :

- son horaire : elle s'exagère en fin de journée
- son intensité : majeure qui peut confiner le patient au lit
- son type : c'est une asthénie globale : musculaire, psychique (déprime, irritabilité ...), génitale (impuissance ou frigidité et il existe souvent une aménorrhée)

2- MELANODERMIE :

due à la décharge permanente d'ACTH (donc de MSH en parallèle) suite à l'absence de cortisol.
signe constant permettant le diagnostic de la maladie.

- La pigmentation cutanée :
 - elle est faite de nappes bronzées sur lesquelles se détachent des macules brun sépia, elle est particulièrement marquée aux :
 - zones découvertes exposées à la lumière (décolleté)
 - zones de frottement : bretelles, ceinture, zones d'appui des avant-bras, genoux ...
 - régions normalement pigmentées : mamelon des seins, régions génitales
 - elle est tout à fait typique aux mains :
 - face palmaire : au niveau des plis de flexion (éminences thénar et hypothénar respectées)
 - face dorsale : au niveau des plis de flexion-extension interphalangiens)
 - les ongles sont entourés d'un halo brun et souvent striés de traînées brunes.
 - les cicatrices doivent être recherchées car elles se pigmentent.
- la pigmentation muqueuse : elle est également spéciale :
 - au niveau de la bouche : elle est faite de petites taches ardoisées
 - elle siège au niveau des gencives, joues et du palais.

Remarques : -la mélanodermie est difficilement analysable chez les noirs

- elle peut être marquée voire au contraire absente chez les sujets à peau très pale.

3-AMAIGRISSEMENT :

signe essentiel. Il est important (plusieurs kilos), rapide (en quelques mois) et s'accompagne d'une véritable fonte musculaire.

4-hypotension artérielle :

Tension artérielle basse en moyenne : 90 mm Hg de systolique, 50 mm Hg de diastolique avec parfois des lipothymies voire syncopes.

5-troubles digestifs :

-anorexie surtout

-Les autres signes digestifs à type de nausées, vomissements, douleurs abdominales sont retrouvés dans la forme aigue de l'insuffisance surrénale et sont un signe d'alarme pour un traitement substitutif corticotrope urgent afin d'éviter la déshydratation, le collapsus et l'état de choc hypovolemique et coma surrénalien

▪Insuffisance Surrénale Aigue :

Une insuffisance surrénale chronique (lente) peut devenir aigue suite à un stress (infection, traumatisme, chirurgie..). Cette forme aigue est une urgence médicale.

Elle se présente avec une altération de l'état général, une asthénie extrême, des troubles psychiques (confusion, délire), troubles digestifs (vomissements, diarrhées, douleurs abdominales) puis une évolution vers la déshydratation, collapsus, coma voire le décès si le patient n'est pas substitué par un traitement substitutif hormonal corticotrope en urgence.

B -HYPERCORTICISMES : SYNDROME DE CUSHING

Forme typique de description

▪ 4 signes essentiels :

1-MODIFICATION DE LA MORPHOLOGIE :

a- obésité facio-tronculaire :(Fig1)

- visage bouffi, arrondi, erythrosique au niveau des pommettes : «c'est le visage de pleine lune »(Fig2)
- cou court, épais avec au niveau de la nuque une boule de graisse dure formant «la bosse de bison»(Fig3)
- tronc épais infiltré de graisse (dos, épaules, seins)
- abdomen déjà moins volumineux
- racine des membres encore épaisse
- fesses« plates »ainsi que les avant-bras et les jambes.

b- amyotrophie :

elle est souvent considérable, surtout aux membres (mollets en particulier) contrastant avec l'obésité facio-tronculaire) ; elle entraîne une asthénie musculaire.

c- les signes cutanés :

- vergetures pourpres (abdomen, racine des cuisses, partie supérieure des seins, racine des bras) : elles sont verticales. (Fig4)
- hyperpilosité surtout au visage (fin duvet) parfois aux membres et au thorax
- acné surtout au dos
- troubles de la cicatrisation souvent très importants (ralentissement de la cicatrisation des plaies)

2-HYPERTENSION ARTERIELLE :

A peu près constante, précoce, systolo-diastolique.

3-DIABETE SUCRE :

- peut être évident avec polyurie, polydipsie, polyphagie
- en règle latent : intolérance au glucose découverte par les épreuves biologiques.

4-OSTEOPOROSE :

A peu près constante avec :

- douleurs vertébrales, pelviennes
- parfois des fractures spontanées.

► 2 signes importants :

1-TROUBLES SEXUELS :

- aménorrhée constante
- troubles de la libido.

2-TROUBLES PSYCHIQUES :

- syndromes dépressifs le plus souvent voire des états mélancoliques
- parfois syndromes d'excitation : état maniaque, délire, hallucinations....



Fig1.- Obésité facio-tronculaire



Fig2.- « visage de pleine lune »



Fig3.- « Bosse de bison »



Fig 4.- vergetures larges verticales.

3- REFERENCES :

- A.Tabarin.Syndrome de Cushing. EMC Endocrinologie-Nutrition.2015
- J.Pernet, P.Ray. Insuffisance surrénale aigue chez l'adulte . EMC - Médecine d'urgence 2019
- Référentiels des Collèges Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques 5^e edition 2021